

Cicli di vita e Autodeterminazione

Percorsi nella Disabilità · Sessione 11 · 5 maggio 2026

Questa lezione tocca uno dei nodi più concreti del lavoro sociale con le persone con disabilità: cosa significa diventare adulti quando il mondo intorno a te stenta a riconoscerti come tale? E soprattutto: come si lavora davvero per promuovere l'autodeterminazione, senza ridurla a uno slogan? Preparati — ci sono concetti potenti e qualche scomoda verità.

I cicli di vita: uno sguardo evolutivo sulla persona

Ogni persona attraversa delle fasi della vita — infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia. Ovvio? Sì. Eppure, quando si lavora con persone con disabilità, questo sguardo evolutivo viene troppo spesso messo da parte.

Considerare i cicli di vita significa guardare la persona in modo globale e in continua evoluzione: le sue risorse e i suoi bisogni cambiano nel tempo. Chi la accompagna — educatori, famiglie, operatori — deve sapersi adattare a questi cambiamenti, anticiparli e sostenerli.

Strumento centrale in quest'ottica è il **Progetto di Vita**, che deve: - tenere conto dell'evoluzione dei bisogni nel tempo - fare da bussola ai piani educativi individuali (PEI) e ai piani sociali individuali (PSI) - accompagnare la persona attraverso le transizioni, non limitarsi a fotografarne lo stato attuale

La **famiglia** è il filo rosso che attraversa tutta la vita della persona con disabilità. Anche la famiglia cambia, si trasforma, invecchia — e il progetto di vita deve tenere conto di questa evoluzione.

L'adulità come diritto: storia di un'idea che stenta ad affermarsi

Fino agli inizi del '900, diventare adulti significava compiere certi riti di passaggio ben definiti: maggiore età, matrimonio, militare, genitorialità. La transizione era rigida, socialmente codificata, scontata.

In questa visione, le persone con disabilità non trovavano posto. L'immagine dominante era duplice: la persona malata bisognosa di cure, oppure **l'eterno bambino**. Come scrive **Carlo Lepri** nell'introduzione al suo libro *Diventare grandi*:

"Nell'immaginario collettivo, le persone con disabilità intellettiva sono da sempre gli eterni ragazzi, i Peter Pan da trattenere in un'infanzia perenne all'interno di luoghi senza storia e senza tempo, come a The Never Land."

A partire dagli anni '70, i movimenti sociali delle persone con disabilità e delle loro famiglie hanno promosso un **cambio di paradigma**: il deficit non risiede nella persona, ma è prodotto da un ambiente che, con le sue barriere fisiche, culturali e psicologiche, non consente la piena partecipazione alla vita sociale.

Questo è il cuore dell'approccio promosso dalla **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** — adottata nel 2006 e ratificata dalla Svizzera solo nel 2014, dopo otto anni. **Il fatto che ci siano voluti così tanti anni la dice lunga su quante resistenze culturali ci siano ancora.**

Contemporaneamente, il concetto stesso di adulità si è evoluto: non è più una fase rigida legata all'anagrafe, ma un percorso individuale determinato da mete e obiettivi personali. **Questo beneficia anche le persone con fragilità, che trovano maggiore permeabilità nel passaggio verso la vita adulta.** Essere adulti, oggi, significa accedere a una molteplicità di ruoli: guadagnarsi da vivere, costruire relazioni affettive e sessuali, scegliere dove vivere, coltivare interessi, partecipare alla vita sociale.

Il concetto di liminalità: la terra di mezzo

Qui arriva uno dei concetti più potenti di questa lezione, coniato dall'antropologo **Robert F. Murphy** nel suo libro *Il silenzio del corpo*.

Liminalità è quella condizione di "terra di mezzo" che si attraversa nel passaggio da una fase all'altra della vita. Non si è più quello che si era prima, non si è ancora quello che si diventerà. È uno stato sospeso, ambiguo — come essere bloccati a metà di un corridoio tra due stanze, senza poter tornare indietro né andare avanti.

Murphy usava questo termine — preso dall'antropologia dei riti di passaggio — per descrivere la condizione delle persone con disabilità: non più bambini cronologicamente, ma non ancora pienamente adulti socialmente.

Il problema è che mancano spesso quei **riti di transizione** — passaggi simbolici — che permettono di uscire da questa terra di mezzo. **Prendere la patente, il primo viaggio da soli, la prima uscita con i pari, il passaggio al settore adulti in un'istituzione: sono piccole celebrazioni che segnano un cambiamento di status. Per molte persone con disabilità, questi momenti non vengono riconosciuti né celebrati.**

Il risultato? **La persona con disabilità resta bloccata in questa sospensione duratura: è diventata adulta biologicamente (il corpo cambia, gli ormoni seguono il loro percorso), ma non viene riconosciuta come tale socialmente.** È ancora il Peter Pan di Lepri — tenuto in un'infanzia perenne non per sua scelta, ma per quella degli adulti intorno a lui.

L'articolo di **Giovanni Pellegrini** sull'esposizione *Tu! Un percorso sulla diversità* ci ricorda che questa condizione liminale non è esclusiva delle persone con disabilità. Come scriveva Murphy:

"Le persone compromesse fisicamente per lungo tempo non sono né malati né sani, né morti né pienamente vivi, né fuori dalla società né totalmente partecipi. Sono esseri umani, ma i loro corpi sono deformati o malfunzionanti, lasciando nel dubbio la loro piena umanità."

La disabilità, in questa lettura, diventa uno specchio che interroga tutti noi sulla nostra comune vulnerabilità.

Autonomia dipendente: liberarsi da un falso mito

Uno degli errori più comuni — e più dannosi — è credere che autonomia significhi "fare tutto da soli". Questa idea è non solo sbagliata, ma produce discriminazione ed esclusione, cristallizzando le persone con disabilità in una condizione di liminalità permanente.

Il filosofo **Edgar Morin** offre il concetto chiave: l'**autonomia dipendente**.

"Il concetto di autonomia è complementare a quello di dipendenza: per essere autonomi bisogna essere dipendenti. L'indipendenza si sviluppa insieme alla dipendenza. Più l'essere diventa autonomo, più è complesso, e più questa complessità dipende dalle complessità eco-organizzatrici che la alimentano."

Nessuno di noi è davvero autonomo in senso assoluto. Siamo autonomi perché ci sono infrastrutture, reti di relazioni, persone che si prendono cura di noi, sistemi di welfare, trasporti, commercio.

Questa stessa riflessione vale per le persone con disabilità. Come sottolinea **Angelo Nuzzo**, docente SUPSI: autodeterminazione e indipendenza non significano controllo assoluto sulla propria vita. Significano **essere l'agente causale** delle scelte e delle decisioni che contano davvero per orientare la propria vita.

Il passaggio necessario è da una **visione individualistica** (la persona ce la fa o non ce la fa in base alle sue abilità) a una **prospettiva sistemica**, in cui la persona è sempre in relazione con il contesto sociale, culturale, politico ed economico. **Il problema non è nella persona — è nell'interazione tra persona e contesto.**

Le tre condizioni per una transizione riuscita verso l'adulthood

Carlo Lepri identifica tre condizioni essenziali e interdipendenti perché la transizione verso l'adulthood possa avvenire:

1. **Accesso a ruoli valorizzanti** tipici dell'età adulta

2. **La possibilità di diventare grandi deve comparire il prima possibile** nella testa e nella pratica di famiglie e agenzie educative

3. **Potenziamento di tre processi psicologici:**

- processi di individuazione (conoscenza di sé, incontro con potenzialità e limiti)
- processi di autonomia dipendente (percepirsi separati dagli altri, ma riconoscere il bisogno di aiuto)
- processi di autodeterminazione (prendere decisioni che riguardano la propria vita senza essere condizionati dagli altri)

La ricerca internazionale conferma: l'autodeterminazione aumenta con l'età, soprattutto a partire dall'adolescenza, e in seguito a transizioni ben riuscite. Non è legata semplicemente al passare del tempo — è legata alle occasioni concrete di fare esperienza e ai ruoli valorizzanti che la persona riesce a raggiungere.

Il concetto di autodeterminazione

L'autodeterminazione come concetto specifico si è sviluppata nell'educazione speciale grazie a: - studi sulla transizione dall'adolescenza all'età adulta - teorie della normalizzazione e della valorizzazione dei ruoli sociali - movimenti di **self advocacy** nati negli Stati Uniti

Rientra nel paradigma della Qualità di Vita ed è uno dei suoi domini. L'autore di riferimento per eccellenza è **Michael Wehmeyer**, che dagli anni '90 lavora su questo tema con numerosi colleghi.

La definizione core:

L'autodeterminazione è la possibilità di prendere delle decisioni secondo le proprie preferenze, i propri valori e i propri obiettivi, senza interferenze esterne non giustificate, per aumentare il controllo sulla propria vita e mantenere e/o aumentare la propria qualità di vita.

Nozione centrale: **agente causale**. La persona autodeterminata agisce e causa un'azione per raggiungere un obiettivo specifico. Non è un agente passivo, non subisce — è il protagonista della propria vita.

Come costruzione teorica, l'autodeterminazione è un **costrutto multidimensionale**. Caratterizzata da una serie di abilità attraverso le quali le persone (Mithaug e colleghi, 1998): - conoscono ed esprimono i propri interessi, bisogni e capacità - stabiliscono le proprie aspettative e obiettivi al fine di soddisfarli - scelgono, decidono, progettano - agiscono per portare a termine i propri progetti - valutano le conseguenze delle proprie azioni - modificano azioni e progetti per raggiungere i propri obiettivi in modo efficace

È importante capire che le persone hanno una naturale propensione verso comportamenti autodeterminati (Deci e Ryan, 1985). Ma questa propensione non si sviluppa spontaneamente: l'autodeterminazione si apprende, si allena, si acquisisce durante tutto l'arco della vita.

Il modello funzionale di Wehmeyer

Il prof sottolinea molto questo modello perché è concreto e progettabile. È uno strumento — una mappa — che aiuta a capire dove intervenire e come.

Il modello considera **due dimensioni in parallelo**:

Dimensione	Contenuto	Leva operativa
Individuale (capacità)	Le competenze della persona	Percorso di apprendimento
Ambientale (opportunità)	Le occasioni offerte dal contesto	Creare esperienze e spazi di sperimentazione

L'uno non funziona senza l'altro. Puoi lavorare quanto vuoi sulle competenze di una persona, ma se poi non ci sono opportunità concrete di praticarle nel mondo reale, non arriverai a comportamenti autodeterminati. E viceversa: puoi offrire tutte le opportunità del mondo, ma se la persona non ha ancora le competenze per gestirle, le esperienze rischiano di essere troppo lontane dalla sua zona di sviluppo prossimale.

Wehmeyer dà poi grande rilievo al **ruolo dei sostegni**: devono essere presenti lungo tutto l'arco della vita, non solo in momenti particolari.

Le quattro abilità fondamentali dell'autodeterminazione

1. Autonomia Capacità di agire in modo indipendente, in accordo con i propri valori, preferenze e desideri. Implica il processo decisionale e la capacità di scelta. Si sviluppa progressivamente, dalla dipendenza verso l'autonomia comportamentale. La progressione non è lineare — ci si sperimenta, si impara dagli errori, si torna indietro e si riparte.

2. Autoregolazione Abilità di autogestione, automonitoraggio e autoistruzione. Saper definire obiettivi, trovare alternative, fare problem solving. Ma anche — e questo è importante — saper **modificare** gli obiettivi quando necessario, fare un passo indietro, mettere obiettivi intermedi. La prof porta se stessa come esempio: sa che lavora meglio sotto pressione delle scadenze. Conoscendo il proprio funzionamento, può organizzarsi di conseguenza. Anche questa è autoregolazione.

3. Autorealizzazione (self-awareness) Conoscenza adeguata di sé: i propri punti di forza, i propri limiti, il proprio funzionamento. Non si nasce con questa consapevolezza — si acquisisce con l'esperienza, il confronto, le valutazioni delle persone significative.

4. Empowerment Senso di autoefficacia: credere di potercela fare prima ancora di partire. Se una persona ha passato anni sentendosi dire "non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai", farà fatica a sviluppare anche solo un minimo di questa fiducia. Un progetto educativo bellissimo sulla carta rischia di non funzionare se la persona, dentro di sé, non crede minimamente di essere in grado di farcela. L'empowerment non è una qualità che si ha o non si ha — è qualcosa su cui si lavora attivamente.

L'autodeterminazione non è carta bianca

Uno dei momenti più interessanti della lezione è la discussione collettiva su questa domanda: autodeterminarsi significa poter fare qualsiasi cosa?

La risposta è no — e la prof lo chiarisce con un esempio diretto:

"Per essere autodeterminato devo essere capace di avere in mente le conseguenze delle mie scelte. Se so che se vado a 150 in autostrada mi

*tolgono la patente, posso decidere se rispettare o non rispettare il limite.
Questa è la libertà. Questa è l'autodeterminazione."*

Il ruolo dell'educatore, quindi, non è "lasciare carta bianca". È: - **facilitare** l'acquisizione della consapevolezza delle conseguenze - **costruire opportunità** reali di scelta all'interno di vincoli trasparenti - **sostenere** la persona nell'imparare a calcolare le proprie azioni

Un esempio concreto dalla lezione: la gestione alimentare nelle strutture. Chiedere a una persona con sovrappeso cosa vuole mangiare, sapendo già che non potrà avere quello che desidera, è paradossale e disonesto. Costruire invece un progetto condiviso — in cui la persona è consapevole dei vincoli medici, sceglie all'interno di spazi reali, e partecipa agli obiettivi — è un lavoro autenticamente autodeterminante.

Il seminario sulle vignette: l'infantilizzazione sotto i riflettori

Gran parte della lezione è stata dedicata a un seminario con vignette — situazioni brevi che mostrano pratiche educative critiche. Ecco i temi principali emersi.

Vignetta 1: Giulio e il direttore

Un educatore usa l'età mentale come riferimento ("consideravo l'età mentale, non quella cronologica") per giustificare il proprio atteggiamento verso Giulio. Giulio va a lamentarsi dal direttore. Il direttore, dopo aver detto che "prenderà provvedimenti", usa esattamente lo stesso linguaggio infantilizzante: "mangia la tua merendina e vai a fare il riposino".

Questa vignetta mette in luce: - **L'infantilizzazione** come comportamento profondo e spesso inconsapevole, radicato nella cultura istituzionale - L'incoerenza del direttore: annuncia un cambiamento e poi replica lo stesso comportamento - Il paradigma implicito: "l'istituto sa cosa è bene per te" — che esclude la persona dal processo di autodeterminazione

Vignetta 2: il menù e i broccoli

Un educatore propone ai partecipanti di scegliere tra opzioni elaborate (foie gras, faraona ripiena...). Tutti scelgono. Alla fine arrivano broccoli al vapore per tutti.

Questa vignetta mostra la **falsa partecipazione**: far credere a qualcuno di avere una scelta quando in realtà la decisione è già presa è doppiamente disonesto. Crea aspettative, poi le tradisce, e attribuisce la colpa a un terzo (il medico). È un gesto che intacca profondamente la fiducia della persona nell'operatore e nell'istituzione.

Vignetta 3: la maglietta "I Love Autodeterminazione"

Un educatore presenta orgoglioso una maglietta per illustrare il concetto. Ha scelto lui l'idea, il testo in inglese (grazie agli studi di inglese), il colore (grazie ai corsi di cromoterapia). Gli utenti avrebbero voluto mettere un pullover, e soprattutto cambiare educatore.

Questa vignetta mette al centro il **narcisismo professionale**: quando il professionista è talmente convinto di essere bravo da non riuscire più a sentire cosa è importante per l'altro. **Avere corsi e competenze non basta**: ciò che conta è se nella pratica stai davvero lasciando scegliere, o stai realizzando la tua visione di cosa sia bello e buono.

Vignetta 4: Pietro e il casco

Pietro soffre di una lieve forma di automutilazione. Dopo una conversazione con un educatore sull'autodeterminazione, decide autonomamente di togliersi il casco. Gli educatori si precipitano a contenere quella che percepiscono come una situazione pericolosa. Pietro voleva solo liberarsi del casco — e finisce con la camicia di forza.

Questa vignetta mostra la **contraddizione tra il dichiarare di volere l'autonomia e il controllarla nel momento in cui si manifesta**. La domanda che la prof pone è cruciale: **quando valutiamo i rischi, lo facciamo in funzione della zona di sviluppo prossimale della persona, o della nostra zona di confort come operatori e come struttura?**

Il linguaggio come specchio dell'atteggiamento

In più momenti della lezione emerge il tema del **linguaggio infantilizzante**: chiamare "ragazzi" degli adulti di 40-50 anni, usare soprannomi infantili, usare diminutivi ("merendina", "riposino"). **Queste non sono questioni superficiali — sono il termometro del paradigma culturale dentro cui si lavora.**

Verso un approccio inclusivo: il ruolo dell'operatore nei contesti

L'autodeterminazione non si promuove solo lavorando con la persona — si promuove lavorando anche, e forse soprattutto, **sui contesti**. Questo è l'approccio ecologico che attraversa tutta la materia.

Come richiama **Angelo Nuzzo**: gli operatori sociali diventano sempre più **tessitori di relazioni e manutentori dei contesti**. Il lavoro non finisce dentro le mura della struttura. Significa: - **andare a parlare con i vicini e con la portinaia se l'utente butta l'accendino per terra** - **contattare il docente di un corso di tedesco per verificare se è accessibile** - **controllare i bus per capire come ci si arriva autonomamente** - costruire reti informali con negozianti, volontari, associazioni del territorio

Un operatore inclusivo non è uno specialista chiuso nel suo servizio. È qualcuno che esce, apre porte, crea ponti. **Il progetto di vita non si esaurisce dentro il servizio — il servizio è un crocevia, non un confine.**

Attenzione però alla **vicinanza eccessiva**: crea dipendenza e limita l'autonomia. Un caso portato in aula: un educatore che aveva instaurato un legame così forte con un utente che quest'ultimo rifiutava tutti gli altri. Questo non è un successo educativo — è un fallimento, perché non ha promosso l'autodeterminazione ma ha sostituito la rete con se stesso.

La testimonianza del Centro Diurno Il Girasole

La seconda parte della lezione ha ospitato i rappresentanti del **Centro Diurno Il Girasole** di Bellinzona, appartenente alla **Fondazione Madonna di Re**, con la partecipazione diretta di alcune persone con disabilità.

Il centro accoglie fino a 14 persone con disabilità fisica, mentale, psichica, dai 18 anni in su. È aperto da tre anni e ha già costruito numerose collaborazioni esterne — una su tutte la dimostrazione che è possibile lavorare concretamente sull'autodeterminazione partendo da zero.

Il principio guida: i programmi vengono costruiti e modificati **con** le persone, non **per** le persone.

Strumenti concreti di autodeterminazione nel centro:

- **Progetto di Accompagnamento Educativo (PAE)**: costruito e condiviso con la persona stessa, orientato alla promozione della qualità di vita
- **Scatola delle proposte**: sempre a disposizione; chiunque può inserire idee o segnalare situazioni di mancato rispetto
- **Assemblea mensile**: spazio in cui tutti possono esprimersi liberamente su temi generali, reclami, proposte, turni
- **CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)**: pittogrammi, agende visive, sistemi di comunicazione vocale — per garantire a tutti la possibilità di comunicare e capire
- **Lingua facile**: usata in tutti gli ambiti del centro
- **Giornale interno**: ogni persona scrive articoli su temi di propria scelta; chi non sa scrivere partecipa con le proprie idee
- **Video su Instagram con la RSI**: le persone stesse si presentano e parlano di affettività, sessualità, accesso alla città

Collaborazioni con il territorio: Biblioteca cantonale, Tavolino Magico (due volte a settimana), Bar Cervo/Vero Caffè, officina biciclette, mercati cittadini, RSA. Ognuna di queste collaborazioni nasce dalle richieste e dagli interessi delle persone del centro, e viene costruita sulle loro competenze e aspirazioni.

Autodeterminazione e qualità della vita

L'autodeterminazione rientra nel modello di **Qualità della Vita (QdV)** elaborato da **Schalock e Verdugo Alonso** come uno degli otto domini principali:

Dominio	Dominio
Benessere emozionale	Relazioni interpersonali
Benessere materiale	Sviluppo personale
Benessere fisico	Autodeterminazione
Inclusione sociale	Diritti

Il modello si declina su tre livelli (micro, meso, macro) e considera sia indicatori soggettivi che oggettivi. La ricerca di **Lachapelle e colleghi (2005)** ha mostrato una correlazione significativa tra autodeterminazione e QdV soggettivamente percepita — **ma i livelli di autodeterminazione risultano sistematicamente più bassi di quelli di QdV.**

Questo significa: i servizi hanno migliorato le condizioni di vita delle persone, ma non hanno ancora creato abbastanza condizioni perché le persone imparino a fare le cose per se stesse. È il prossimo passo.

Il **capability approach** di **Amartya Sen** aggiunge un'ulteriore prospettiva: il benessere di una persona dipende non solo dalle risorse disponibili, ma dalla sua capacità di trasformarle in concrete realizzazioni nella direzione che lei stessa intende perseguire. **L'enfasi è sulla libertà effettiva di scegliere.** La QdV non si valuta dall'esterno — si valuta a partire da quanto la persona stessa la percepisce.

L'antropologia del limite: la vulnerabilità come condizione umana

L'articolo di **Giovanni Pellegrini** sull'esposizione *Tu! Un percorso sulla diversità* aggiunge una prospettiva filosofica che allarga l'orizzonte.

La vulnerabilità non è un'eccezione — è una caratteristica costitutiva di ogni essere umano. La **Dichiarazione di Barcellona** l'ha inserita tra i quattro principi fondamentali dell'essere umano, accanto ad autonomia, integrità e dignità.

"La coperta è sempre troppo corta: se hai freddo alle spalle, sollevi la coperta e scopri i piedi. Se hai freddo ai piedi e l'abbassi, si scoprono le spalle. Abbiamo sempre qualcosa di scoperto. L'uomo è fatto così." —

Claudio Moneta, vittima di un incidente stradale

Le persone con disabilità non sono una specie a parte: sono una **metafora della condizione umana**. Robert F. Murphy — antropologo che ha studiato popolazioni remote e poi è diventato tetraplegico — lo descrive con chiarezza: la disabilità porta con sé tutti i tratti tipici dell'incontro con l'alterità: paure, miti, diffidenza, pregiudizi.

Il limite non è solo mancanza o deficit — è lo spazio del possibile, del vivibile, dell'umano. L'**antropologia del limite** non esalta il difetto, ma non lo ignora: lo assume come elemento che struttura radicalmente la persona. Per il lavoro sociale: questo sguardo ci ricorda che lavorare con le persone con disabilità è lavorare con l'umano nella sua forma più essenziale. Non è una specializzazione ai margini — è al centro.

Concetti chiave

Termine	Significato
Cicli di vita	Traiettorie evolutive che ogni persona attraversa (infanzia, adolescenza, adultità, vecchiaia); la progettazione educativa deve tenerne conto
Liminalità	Stato di "terra di mezzo" tra due fasi della vita; le persone con disabilità rischiano di restarvi bloccate per mancanza di riti di transizione (Murphy)
Adultità	

Termine	Significato
	Non dipende solo dall'anagrafe, ma dall'accesso a ruoli valorizzanti e dalla possibilità di prendere decisioni
Autonomia dipendente	Concetto di Morin : l'autonomia si fonda sulle relazioni e le dipendenze dal contesto — vale per tutti, non solo per le persone con disabilità
Autodeterminazione	Possibilità di prendere decisioni in base ai propri valori e obiettivi, senza interferenze esterne non giustificate; agire come agente causale (Wehmeyer)
Agente causale	La persona che mette in atto azioni con intenzionalità per raggiungere obiettivi specifici; opposto di agente passivo
Modello funzionale	Modello di Wehmeyer: dimensione individuale (capacità) + dimensione ambientale (opportunità) + sostegni = comportamento autodeterminato
Empowerment	Senso di autoefficacia; credere di potercela fare; componente essenziale per seguire un progetto educativo
Autoregolazione	Capacità di gestire e modificare obiettivi, monitorarsi, fare problem solving
Autorealizzazione	Conoscenza di sé: punti di forza e limiti; si acquisisce con l'esperienza e il confronto
Infantilizzazione	Trattare adulti come bambini (nel linguaggio, nelle scelte, nelle decisioni); ostacola direttamente l'autodeterminazione
Self advocacy	Movimento nato negli USA: le persone con disabilità si battono per i propri diritti in prima persona
CAA	

Termine	Significato
	Comunicazione Aumentativa Alternativa; strumenti (pittogrammi, agende, sistemi vocali) per garantire a tutti la possibilità di comunicare
PAE	Progetto di Accompagnamento Educativo; strumento per costruire un percorso condiviso con la persona
Qualità della Vita (QdV)	Modello di Schalock e Verdugo Alonso con 8 domini; l'autodeterminazione è uno di essi
Capability approach	Approccio di Amartya Sen : il benessere dipende dalla capacità di trasformare risorse disponibili in realizzazioni concrete nella direzione scelta dalla persona
Scaffolding	Impalcatura di sostegno dell'esperto che si ritira progressivamente man mano che la persona acquisisce autonomia (Bruner/Vygotskij)

Domande di orientamento allo studio

Che cos'è la liminalità e perché è rilevante per le persone con disabilità?

La liminalità è uno stato di "terra di mezzo" nei passaggi tra le fasi della vita: non si è più quello che si era, non si è ancora quello che si diventerà. Il termine viene dall'antropologo Robert F. Murphy, che lo ha usato per descrivere la condizione delle persone con disabilità: mancano spesso i riti di transizione simbolici che permettono di acquisire lo status di adulto. Il risultato è una sospensione duratura — la persona è diventata adulta biologicamente ma non è riconosciuta come tale socialmente. Resta bloccata nell'immagine dell'"eterno bambino" (Lepri), non per propria scelta, ma per le rappresentazioni culturali degli adulti intorno a lei.

Cosa significa autonomia dipendente e perché smonta il falso mito del

"fare tutto da soli"? L'autonomia dipendente è un concetto di Edgar Morin:

l'autonomia non è indipendenza assoluta, ma si fonda sulle relazioni e sulle dipendenze dal contesto. Tutti noi dipendiamo da altri per poter essere autonomi —

reti sociali, infrastrutture, sistemi economici. Sostenere che le persone con disabilità "non possono essere autonome perché non fanno le cose da soli" è un errore concettuale che produce discriminazione. L'obiettivo non è eliminare la dipendenza, ma aumentare i margini di scelta all'interno di un sistema di interdipendenze significative. Come sottolinea Nuzzo: autodeterminazione significa essere l'agente causale delle scelte fondamentali della propria vita, non avere il controllo assoluto su tutto.

Quali sono le quattro componenti dell'autodeterminazione secondo il modello di Wehmeyer? Le quattro componenti sono: autonomia (capacità di agire in modo indipendente seguendo i propri valori e desideri, con un processo decisionale sviluppato), autoregolazione (definire obiettivi, monitorarsi, modificarli quando necessario, fare problem solving), autorealizzazione (conoscenza di sé, dei propri punti di forza e limiti, acquisita con l'esperienza) ed empowerment (senso di autoefficacia, fiducia nelle proprie possibilità di successo). Queste componenti non sono qualità innate — si sviluppano attraverso l'apprendimento e l'esperienza nell'arco di tutta la vita.

In cosa consiste il modello funzionale di autodeterminazione di Wehmeyer e qual è la sua utilità pratica? Il modello considera due dimensioni complementari che devono crescere in parallelo: la dimensione individuale (le competenze della persona, sviluppate attraverso l'apprendimento) e la dimensione ambientale (le opportunità offerte dal contesto per sperimentarsi). Il terzo elemento sono i sostegni, che devono essere presenti lungo tutto il ciclo di vita. Il modello è "funzionale" perché fornisce una mappa concreta per la progettazione educativa: non basta lavorare solo sulle competenze senza creare opportunità, né solo sulle opportunità senza sostenere lo sviluppo delle competenze. I due piani devono essere calibrati in modo da stare nella zona di sviluppo prossimale della persona.

Qual è la differenza tra promuovere l'autodeterminazione e "lasciare carta bianca"? L'autodeterminazione non significa assenza di vincoli. Significa essere consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte e agire come agente causale all'interno dei vincoli reali (medici, legali, istituzionali). Il ruolo dell'educatore è facilitare la comprensione di questi vincoli, costruire spazi di scelta reali e trasparenti, e sostenere la persona nell'acquisire la consapevolezza delle

proprie azioni. La falsa partecipazione — far scegliere sapendo che la scelta non sarà rispettata — è peggio dell'assenza di scelta, perché erode la fiducia della persona nell'operatore.

Cosa si intende per approccio ecologico nel lavoro per

l'autodeterminazione? L'approccio ecologico significa che il lavoro non si concentra solo sulla persona, ma anche sui contesti in cui vive. L'operatore sociale diventa "tessitore di relazioni e manutentore dei contesti" (Nuzzo): lavora con i vicini, con i negozianti, con le istituzioni del territorio. Le opportunità di sperimentarsi devono essere costruite nella comunità, fuori dalla struttura protetta. Questo amplia il perimetro del lavoro educativo e lo rende più incisivo — ma richiede anche di uscire dai confini del servizio e costruire reti informali.

Quali condizioni sono necessarie perché la transizione verso l'adulthood sia ben riuscita? Secondo Lepri, tre condizioni essenziali e interdipendenti: accedere a ruoli valorizzanti tipici dell'età adulta; che la possibilità di diventare grandi entri il prima possibile nella testa e nella pratica di famiglie e agenzie educative; e il potenziamento di tre processi psicologici — individuazione (conoscenza di sé), autonomia dipendente (percepirsi separati ma riconoscere il bisogno d'aiuto), autodeterminazione (prendere decisioni sulla propria vita). La ricerca internazionale mostra che l'autodeterminazione cresce più in relazione alle occasioni di fare esperienza e ai ruoli valorizzanti che al semplice passare del tempo.

Collegamenti

- **Lezione precedente (paradigma medico vs ecologico):** questa lezione concretizza il cambio di paradigma già introdotto, applicandolo al dominio dell'autodeterminazione e ai cicli di vita
- **ICF e approccio bio-psico-sociale:** il modello funzionale di Wehmeyer è coerente con l'ICF — considera fattori personali e ambientali in interazione
- **Qualità di vita (QdV):** l'autodeterminazione è uno dei domini centrali del modello di Schalock e Verdugo Alonso
- **Sostegni naturali e specializzati:** tema già affrontato, qui declinato nel contesto specifico dell'autodeterminazione e dei cicli di vita

- **Da approfondire:** la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità — principi generali e articoli specifici sull'autonomia e la partecipazione
- **Da approfondire:** sessualità e affettività nelle persone adulte con disabilità — tema accennato dalla testimonianza del Centro Il Girasole, spesso negletto nei servizi